Tutoria UC14 · Resumo para a prova final

roxo caiu (provas/APFs) · amarelo dica dos tutores · ✎ pegadinha · × seu erro na APF

SP1 · ABDOME AGUDO

AS 5 SÍNDROMES E O EXAME INICIAL

5 síndromes → exame INICIAL → conduta

Inflamatório	dor que piora e localiza, febre	**USG (biliar/pelve) · TC**	apendicite, colecistite, diverticulite, pancreatite (clínica)
Perfurativo	dor súbita, difusa, tábua, Jobert	**RX 3 incidências (ar livre)**	laparotomia/laparoscopia de urgência
Obstrutivo	cólica, distensão, vômitos, parada de gases	**RX abdome em pé + deitado → TC**	jejum + SNG + hidratação; cirurgia se sofrimento
Vascular	dor súbita desproporcional, FA, lactato ↑	**ANGIO-TC**	heparina + revascularização
Hemorrágico	dor + choque; mulher fértil	**β-HCG + USG (FAST)**	cirurgia (ectópica rota, AAA)

- Abdome agudo = dor abdominal de início recente (horas a poucos dias) que exige decisão rápida, clínica ou cirúrgica. O raciocínio que ela cobra é sempre o mesmo: **síndrome → exame inicial → conduta**.
- "Exame INICIAL" = rotina de abdome agudo: RX de tórax PA em ortostase + abdome em pé + abdome deitado (as "3 incidências"). TC é o mais sensível, mas não é o inicial. Isquemia → angio-TC · vesícula → USG · mulher fértil → β-HCG + USG transvaginal · diverticulite → TC com contraste.
- TUTORA 20/10 Laboratório do abdome agudo: hemograma (leucocitose com desvio = inflamatório/infeccioso), PCR, **lipase/amilase** (≥ 3× = pancreatite), bilirrubinas + FA/GGT + TGO/TGP (via biliar), **lactato + gasometria** (isquemia/sofrimento de alça), Na/K/Cl (vômitos → hipocalemia + alcalose hipoclorêmica), ureia/creatinina, **β-HCG** em mulher fértil, EAS (cólica renal/ITU), coagulograma + tipagem (pré-operatório). Tabela completa em Laboratório por quadro.

✎ *T11 Q4: AINE + dor súbita + abdome tenso = perfuração → exame inicial =* RX em 3 incidências *(a TC era o distrator) · T9 Q2: obstrução →* RX de abdome *· T11 Q2: idoso distendido →* radiografias abdominais*.*

✎ *APF T12 (sua): obstrutivo =* cólica + parada de gases e fezes *(× Murphy, × intussuscepção, × cirurgia na maioria) · perfurativo =* pneumoperitônio no RX em ortostase é frequente *(× "tratamento clínico na maioria").*

✎ *T11 Q3: pancreatite =* abdome agudo CLÍNICO *(inflamatório de tratamento clínico) que pode evoluir com complicações sistêmicas — não é cirúrgico desde o início.*

O que procurar no raio X do abdome agudo



Ar sob as cúpulas
pneumoperitônio → PERFURAÇÃO



Níveis hidroaéreos em escada
distensão de delgado → OBSTRUÇÃO



"Grão de café" / U invertido
alça sigmoide gigante → VOLVO

Rotina de abdome agudo = tórax PA em pé + abdome em pé + abdome deitado (as "3 incidências")

SEMIOLOGIA QUE A PROVA USA

Onde dói → o que pensar

roxo = região que já caiu em prova (T9–T11 / APF)

Hipocôndrio D Colecistite · cólica biliar Colangite · hepatite Abscesso hepático	**Epigástrio** Úlcera (perfurada) · DRGE Pancreatite (em faixa) IAM inferior!	**Hipocôndrio E** Baço (infarto/ruptura) Pancreatite (cauda)
Flanco D Cólica renal · pielonefrite Cólon ascendente	**Mesogástrio** Apendicite INICIAL Isquemia mesentérica Obstrução de delgado	**Flanco E** Cólica renal Cólon descendente
Fossa ilíaca D Apendicite (McBurney) Ectópica · anexos Crohn ileal	**Hipogástrio** Cistite · retenção DIP · útero	**Fossa ilíaca E** Diverticulite Volvo de sigmoide Ectópica · anexos

Dor difusa + abdome em tábua = peritonite (perfurativo) · dor desproporcional ao exame = vascular

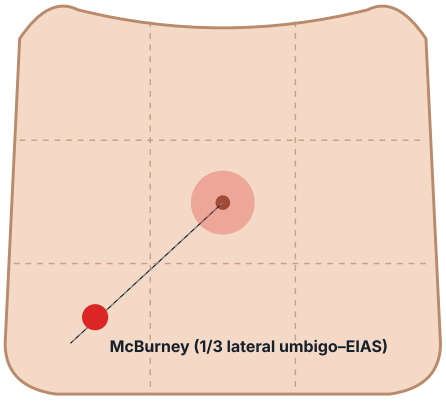
- Dor visceral (mal localizada, linha média, cólica) → parietal (localizada, contínua, piora ao mover) = inflamação chegando ao peritônio. Na apendicite: **periumbilical → FID**.
- **Blumberg** (descompressão dolorosa no ponto de McBurney) · **Rovsing** (palpar FIE dói na FID) · psoas/obturador (apêndice retrocecal/pélvico) · **Murphy** (parada da inspiração à palpação do HD = colecistite) · **Giordano** (punho-percussão lombar = rim) · Cullen/Grey-Turner (equimose periumbilical/flancos = pancreatite hemorrágica).
- Sinal de Jobert: timpanismo no hipocôndrio direito, onde deveria haver macicez hepática = pneumoperitônio → úlcera perfurada.
- Peritonite: paciente imóvel, abdome em tábua, RHA abolidos. Obstrução: distensão, RHA **aumentados, metálicos, "em rajadas"** (fase inicial) → silêncio (fase tardia).
- Idoso: dor e febre menos intensas, exame pobre — subestima a gravidade; dor desproporcional ao exame = pensar em vascular.

✎ *T9 Q1 e APF: timpanismo em HD + ausência de macicez hepática =* úlcera perfurada com pneumoperitônio.

INFLAMATÓRIO: APENDICITE · DIVERTICULITE

Apendicite: a dor migra

visceral (mal localizada, periumbilical) → parietal (fixa na fossa ilíaca direita)



1º · dor periumbilical, mal definida
visceral; anorexia, depois náusea/vômito

2º · migra para a fossa ilíaca direita
parietal: contínua, piora ao mover; febre baixa

Exame: Blumberg, Rovsing, psoas, obturador
Alvarado ≥ 7 = alta probabilidade → cirurgia

Apendicectomia VLP + ATB (cefazolina ou ceftriaxona + metronidazol)

- Apendicite: dor periumbilical que migra para FID, anorexia, náusea/vômito depois da dor, febre baixa, Blumberg. Diagnóstico **clínico** (Alvarado ≥ 7); imagem se dúvida (USG em criança/gestante, TC no adulto). Conduta: **apendicectomia** (VLP) + ATB (cefazolina ou ceftriaxona + metronidazol).
- Diverticulite = "apendicite da esquerda": idoso, constipação crônica, dor em FIE + febre. Exame: **TC com contraste** (Hinchey). Não complicada: dieta líquida, analgesia, ATB VO (amoxi-clav ou cipro + metronidazol 7–10 d; pode dispensar ATB em imunocompetente selecionado). Abscesso > 3–4 cm: drenagem percutânea. Peritonite purulenta/fecal (Hinchey III–IV): cirurgia (Hartmann). **Colonoscopia só após 6–8 semanas** (nunca na fase aguda).

✎ *T11 Q1: 64 a, constipada, dor em QIE + febre →* diverticulite colônica aguda *· T10 Q3: periumbilical → FID + Blumberg →* apendicite.

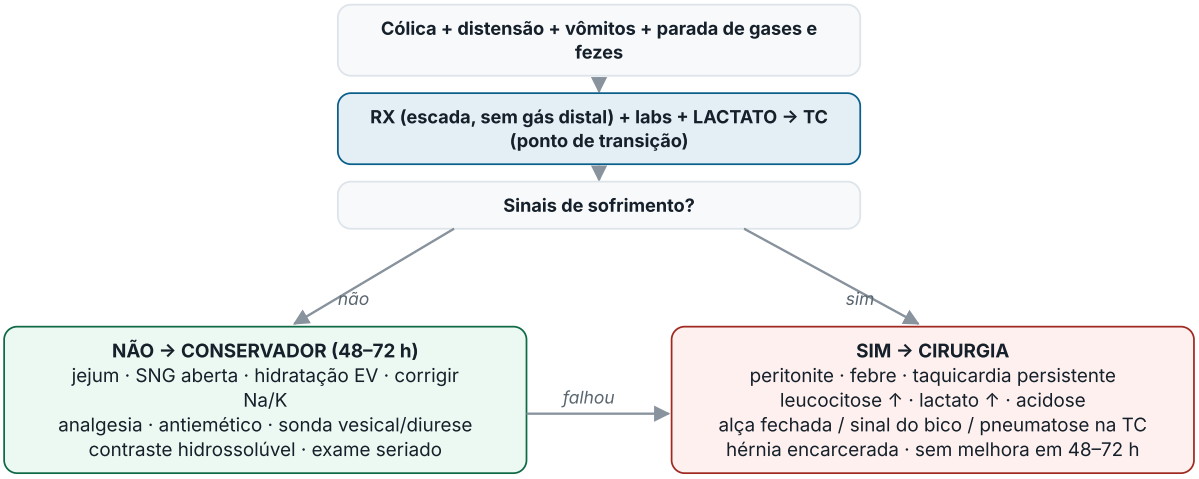
✎ *APF T12 discursiva (sua):* "preencha a primeira prescrição" do paciente com apendicite → dieta zero · SF/Ringer EV · dipirona 1 g EV 6/6 h (± morfina) · ondansetrona 4 mg EV 8/8 h · ATB (cefazolina 2 g na indução; complicada: ceftriaxona 2 g/d + metronidazol 500 mg 8/8 h) · sinais vitais/diurese · exames (hemograma, PCR, EAS, β-HCG) · apendicectomia VLP. *Ordem: dieta → hidratação → analgesia → antiemético → ATB → cuidados → exames → procedimento.*

PERFURATIVO

- Dor **súbita, lancinante**, epigástrica que vira difusa, abdome em tábua, Jobert. Causa principal: úlcera péptica perfurada (AINE, H. pylori, tabaco).
- RX: **pneumoperitônio** (ar sob as cúpulas). Conduta: jejum, SNG, hidratação, IBP EV, ATB, **cirurgia de urgência** (rafia + epiploplastia) e depois erradicar H. pylori.

OBSTRUTIVO

Obstrução intestinal: conservador ou cirurgia



Causa nº 1 no delgado = bridas (cirurgia prévia) · cólon do idoso = neoplasia, volvo, fecaloma · volvo sem sofrimento = descompressão endoscópica

- Cólica + distensão + vômitos + **parada de eliminação de gases e fezes**. Delgado alto: vômitos precoces e biliosos, pouca distensão. Cólon: distensão grande, vômitos tardios/fecaloides.
- Causa nº 1 de obstrução de DELGADO = bridas/aderências (cirurgia prévia); depois hérnias. Cólon: **neoplasia** (idoso, emagrecimento, fezes afiladas), **volvo de sigmoide** (idoso institucionalizado, constipado — RX "grão de café"/U invertido), fecaloma.
- RX: níveis hidroaéreos **em escada**, distensão (delgado > 3 cm, cólon > 6 cm, ceco > 9 cm), **ausência de gás distal**. TC: **ponto de transição**, causa, sinais de sofrimento (**sinal do bico**, alça fechada, pneumatose, edema de parede, líquido livre).
- Protocolo inicial (sem sofrimento): jejum + SNG aberta + hidratação EV + correção de Na/K + analgesia + antiemético + sonda vesical/diurese + exame seriado; contraste hidrossolúvel (gastrografina) é diagnóstico e terapêutico.
- Conservador × cirurgia: conservador por 48–72 h se estável, sem peritonite, sem sinais de isquemia. **Falha/operar**: peritonite, febre, taquicardia persistente, leucocitose crescente, **lactato** ↑, acidose, alça fechada/sinal de sofrimento na TC, obstrução completa, sem contraste no cólon em 24 h, sem melhora em 48–72 h, hérnia encarcerada.
- Volvo de sigmoide sem sofrimento: **descompressão por retossigmoidoscopia** + sigmoidectomia eletiva (recidiva alta). Com sofrimento: cirurgia.
- Lactato: marcador de hipoperfusão/isquemia de alça (estrangulamento); normal não exclui.

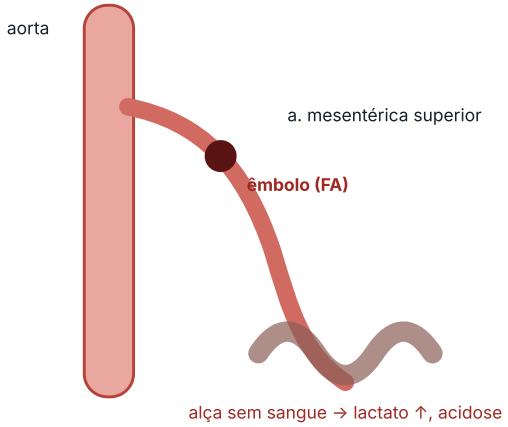
✎ ***Discursiva de obstrução caiu nas 3 turmas:*** *T9 (idoso constipado, "dessa vez não funcionou"), T10 e T11 (bridas pós-cirurgia). Itens que se repetem: diagnóstico sindrômico + etiologia, exames (lab + RX + TC), utilidade do lactato, conduta das primeiras horas, conservador × falha.*

✎ *Erros que custaram ponto: simeticona "para os gases" como conduta (T10) · "USG mostra fezes impactadas onde há aderências" (T11 — USG não vê bridas) · esquecer SNG e diurese (T9).*

VASCULAR · HEMORRÁGICO

Isquemia mesentérica aguda

dor DESPROPORCIONAL ao exame físico



Quem: idoso, FA/IAM recente, aterosclerose

Dor súbita intensa · abdome flácido · diarreia/sangue
lactato ↑ + acidose metabólica

ANGIOTOMOGRAFIA (exame de escolha)

Ressuscitação + HEPARINA plena + ATB
revascularização (embolectomia/endovascular)
peritonite → laparotomia + ressecção

- Isquemia mesentérica aguda: idoso, FA/IAM recente (êmbolo na AMS), dor súbita intensa DESPROPORCIONAL ao exame (abdome flácido), lactato ↑, acidose, às vezes diarreia/sangue. Exame: angio-TC. Conduta: ressuscitação, heparina plena precoce, ATB, revascularização (embolectomia/endovascular); laparotomia se peritonite (ressecar alça necrótica).

- Hemorrágico: gravidez ectópica rota (atraso menstrual, dor súbita em fossa ilíaca, dor no ombro, choque → β-HCG + USG TV → cirurgia) · AAA roto (idoso, tabagista, dor abdominal/lombar + massa pulsátil + choque → cirurgia sem TC se instável).
- Hemorrágico: choque hipovolêmico rápido; FAST ajuda; NEM SEMPRE há irritação peritoneal (sangue irrita pouco no início) — a incorreta da APF T12.

✎ *T10 Q1–2 =* ***APF T12 Q4–5 (o mesmo caso, reaproveitado!)****: 72 a, arritmia, dor 9/10 sem peritonite, lactato ↑ →* isquemia mesentérica → TC contrastada + anticoagulação *(quem marcou "jejum, hidratação, ATB" errou: faltava o essencial) · T9 Q3:* β-HCG + USG transvaginal.

CONSTIPAÇÃO

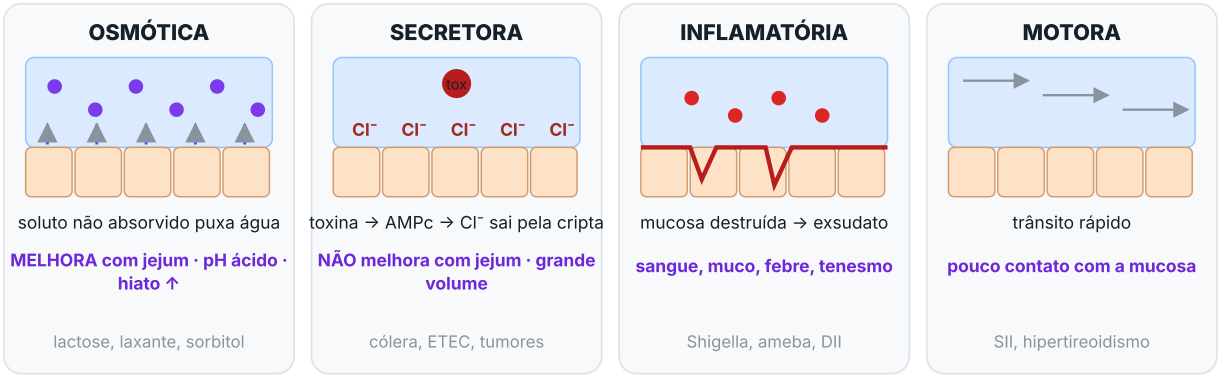
- Roma IV: ≥ 2 de esforço, fezes duras (Bristol 1–2), evacuação incompleta, bloqueio, manobras manuais, < 3 evacuações/semana, em ≥ 25% das evacuações, por 3 meses.
- Alarme (colonoscopia): > 45–50 a, sangue, anemia, emagrecimento, mudança recente do hábito, história familiar de CA colorretal. Tratamento: fibras + água + atividade → laxante osmótico (PEG/lactulose) → estimulante. Criança: desimpactação (PEG) + manutenção + treino de toalete.

SP2 · DIARREIA E PARASITOSES

DEFINIÇÕES E MECANISMOS

- Diarreia = ≥ 3 evacuações amolecidas/líquidas em 24 h. Duração: aguda < 14 dias · persistente 14–29 dias · crônica ≥ 30 dias. Disenteria = sangue/muco.
- > 90% das agudas são infecciosas, transmissão fecal-oral (água/alimento contaminado). Na criança, a maioria é viral (rotavírus, norovírus) e autolimitada em até 7 dias; disenteria = bactéria invasiva (Shigella, Campylobacter, Salmonella, EIEC) — não rotavírus.

Os 4 mecanismos da diarreia



✎ *T11 Q8: Vibrio cholerae → adenilato ciclase → AMPc →* secretora (não regride com jejum) *· T10 Q4: diarreia após leite que melhora ao evitar →* osmótica → teste do H_2 expirado/tolerância à lactose + exclusão *· T9 Q6:* aguda NÃO é 2–4 semanas *· APF T12: 16 dias =* persistente *; osmótica =* cessa com o jejum.

AVALIAÇÃO DA DESIDRATAÇÃO E PLANOS A · B · C

Avaliar a desidratação → escolher o plano (MS)

SEM desidratação → PLANO A (casa)
alerta · olhos normais · bebe normal
SRO após cada evacuação:
< 1 a 50–100 mL · 1–10 a 100–200 mL
> 10 a à vontade · manter dieta
ZINCO 10 mg (< 6 m) / 20 mg 10–14 d
sinais de retorno

COM desidratação → PLANO B (unidade)
≥ 2: irritado, olhos fundos,
BEBE AVIDAMENTE, prega lenta
SRO 50–100 mL/kg em 4–6 h
vomitou? → gastróclise 20–30 mL/kg/h
reavaliar: melhorou → A
piorou → C

GRAVE → PLANO C (EV)
≥ 2: LETÁRGICO, bebe mal/não bebe,
prega > 2 s, TEC > 5 s, pulso fino
SF 0,9% / Ringer — expansão:
< 1 a: 30 mL/kg em 1 h + 70 em 5 h
≥ 1 a: 30 mL/kg em 30 min + 70 em 2h30
SRO 5 mL/kg/h assim que beber

Observar	Sem desidratação	Com desidratação (≥ 2)	Grave (≥ 2, incl. 1 *)
Estado geral	alerta	irritado, intranquilo	* comatoso, hipotônico, **letárgico**
Olhos / lágrimas	normais / presentes	fundos / ausentes	muito fundos / ausentes
Sede	bebe normal	**sedento, bebe avidamente**	* bebe mal ou não consegue
Prega	desaparece rápido	lentamente	muito lenta (> 2 s)
Pulso / TEC	cheio / < 3 s	rápido, fraco / 3–5 s	* muito fraco ou ausente / > 5 s

- Plano A (casa): líquidos + **SRO após cada evacuação: < 1 a 50–100 mL · 1–10 a 100–200 mL · > 10 a à vontade**; manter alimentação; zinco 10 mg/d (< 6 m) ou 20 mg/d (≥ 6 m) por 10–14 dias; ensinar **sinais de retorno** (piora, sangue, vômitos, não bebe, febre, sonolência).
- Plano B (unidade, observado): SRO 50–100 mL/kg em 4–6 h; vomitou? → reduzir/fracionar ou **gastróclise por SNG 20–30 mL/kg/h**; reavaliar → hidratado = A · piorou/letargia = C.
- Plano C (EV) com **SF 0,9% ou Ringer — dois esquemas já caíram** (figura abaixo): cartaz antigo: < 5 anos 20 mL/kg em 30 min, repetir até hidratar (gabarito da sua APF) · cartaz 2023: < 1 ano 30 mL/kg em 1 h + 70 em 5 h; ≥ 1 ano 30 mL/kg em 30 min + 70 em 2h30 (T10). Reavaliar; SRO 5 mL/kg/h assim que beber; depois manutenção (Holliday-Segar: 100 mL/kg até 10 kg, + 50/kg de 10–20, + 20/kg acima) + reposição.

Plano C (EV): os dois esquemas que já caíram

Cartaz antigo do MS
< 5 anos: SF 0,9% 20 mL/kg em 30 min — repetir até hidratar
> 5 anos: SF 30 mL/kg em 30 min + Ringer 70 mL/kg em 2h30
gabarito da APF T12 (Ana Elisa)

Cartaz MS 2023
< 1 ano: 30 mL/kg em 1 h + 70 mL/kg em 5 h
≥ 1 ano: 30 mL/kg em 30 min + 70 mL/kg em 2h30
gabarito da T10 (Q6)

O que nunca muda: GRAVE = Plano C = EV com SF/Ringer · reavaliar · SRO assim que beber

- SRO de osmolaridade reduzida (OMS): **Na 75 mmol/L, glicose 75 mmol/L, osmolaridade 245** (90/111 = SRO antiga) · 1 envelope em 1 L de água, usar em 24 h · soro caseiro ≠ SRO.
- Antibiótico só em: disenteria com comprometimento do estado geral — cartaz 2023: **azitromicina** (até 30 kg: 10 mg/kg no 1º dia + 5 mg/kg/d por 4 d) ou ceftriaxona 50 mg/kg 3–5 d; > 30 kg: cipro 500 mg 12/12 h 3 d · cartaz antigo: ciprofloxacino 15 mg/kg 12/12 h 3 d. Loperamida contraindicada (disenteria, criança). Também cólera grave, imunossuprimido, giárdia/ameba. Ondansetrona (dose única) pode facilitar a TRO.

✎ ***Planos caíram nas 3 turmas**: T11 Q5 e APF (irritado + olhos fundos + bebe avidamente → Plano B na unidade) · T10 Q6 (sonolento, não bebe, TEC 4 s, pulso fino → Plano C) · T9 Q5 (vomitou e ficou letárgico → EV com SF 30 mL/kg; "soro glicofisiológico 1:1 100 mL/kg" é o esquema antigo).*

✎ *APF T11: o suplemento recomendado é o zinco (não probiótico) · APF T12: zinco 10–14 dias, 10 mg < 6 m / 20 mg ≥ 6 m (× "máximo 3 dias") · Shigella → cipro ou azitro + contraindicar loperamida.*

× *Sua APF (discursiva Plano A): volume por evacuação de 1–10 anos é **100–200 mL** (você escreveu 50 mL). Receita completa: SRO (nome, 1 envelope/1 L, volume por evacuação) + zinco (dose, 1×/dia, 10–14 d) + alimentação habitual e líquidos caseiros + ≥ 4 sinais de retorno.*

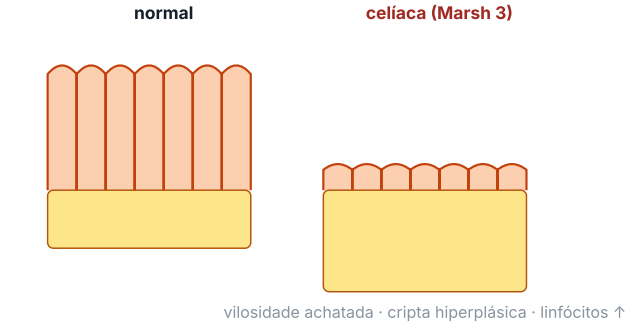
DIARREIA AGUDA NO ADULTO

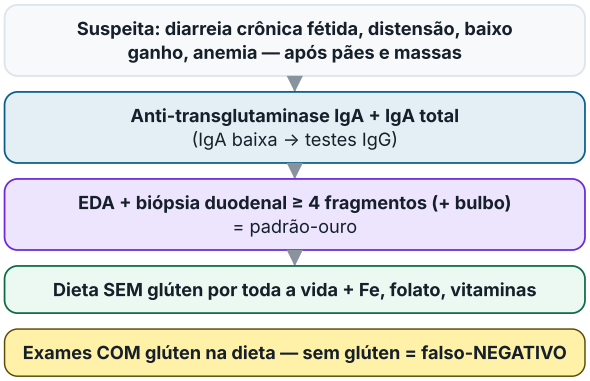
- TUTORA 20/10 Sem gravidade: avaliar desidratação, duração e características das fezes; exames só nos graves; hidratação oral + eletrólitos + dieta leve conforme aceitação. Exames (coprocultura, leucócitos fecais, C. difficile) se: sangue, febre alta, desidratação grave, > 7 dias, imunossuprimido, idoso, surto, uso recente de ATB.
- ATB empírico (cipro 500 mg 12/12 h 3 d ou azitromicina 1 g DU): diarreia invasiva grave, febre alta, sangue — quando não dá para esperar o agente. Loperamida: evitar se sangue/febre.
- TUTORA 20/10 Exames na diarreia: aguda simples = **nenhum**. Grave/desidratado: Na, K, ureia/creatinina, gasometria (**acidose metabólica com ânion gap normal** = perda de bicarbonato; hipocalemia). Invasiva/febre/> 7 d: **coprocultura**, leucócitos fecais/**calprotectina**. Pós-ATB/internado: **toxina do C. difficile** (→ vancomicina 125 mg VO 6/6 h 10 d). > 14 d: **parasitológico (EPF) em 3 amostras**, Ag de Giardia. Crônica: hemograma, ferritina, **anti-tTG IgA + IgA total**, TSH, calprotectina, gordura fecal (Sudan), elastase; pH fecal < 5,5 + substâncias redutoras = má absorção de lactose.

✎ *T10 Q5: palavras que denunciam a errada → "de rotina", "em todos os casos", "restringir/suspender líquidos".*

DOENÇA CELÍACA E DIARREIA CRÔNICA

Doença celíaca: do glúten à biópsia





- Enteropatia autoimune ao **glúten** (trigo, centeio, cevada) em predispostos (HLA-DQ2/DQ8): atrofia de vilosidades + hiperplasia (alongamento) de criptas + linfócitos intraepiteliais (Marsh) → má absorção no duodeno/jejuno proximal (**ferro, folato, cálcio**).
- Clássica (criança após introdução de pães/massas): diarreia crônica com fezes volumosas, pastosas, fétidas; distensão/abdome globoso; perda de peso; baixo ganho estatural; palidez; irritabilidade. Extraintestinal: anemia ferropriva, osteopenia, atraso de crescimento/puberdade, infertilidade, neurológicas, dermatite herpetiforme, hipoplasia de esmalte.
- Diagnóstico: anti-transglutaminase tecidual IgA + IgA total (antiendomísio confirma) → EDA com biópsia duodenal = padrão-ouro (≥ 4 fragmentos da 2ª porção + 1–2 do bulbo). Tudo EM VIGÊNCIA de glúten (sem glúten = **falso-negativo**).
- Tratamento: dieta isenta de glúten por toda a vida + nutricionista + repor ferro, folato, vitaminas, cálcio. A mucosa **se recupera** com a dieta.
- Complicações sem tratamento: desnutrição, baixa estatura, osteoporose, infertilidade, celíaca refratária, **linfoma T associado à enteropatia**, adenocarcinoma de delgado.
- Intolerância à lactose: osmótica, distensão e flatulência após leite → teste do H_2 expirado → restringir/substituir, lactase.

✎ ***Celíaca caiu 2× em discursiva (T9 e T10) + 1 objetiva (T9 Q4)**. Na T9 Q4 eram falsas: "recuperação parcial" e "biópsia após 6 semanas SEM glúten para evitar falso-positivo".*

PARASITOSES

- Dica dos tutores: saber se é protozoário, nematódeo ou cestódeo — o grupo já aponta o remédio (protozoário → nitroimidazol; nematódeo → albendazol/ivermectina; cestódeo → praziquantel).

Parasitoses: primeiro, que bicho é

PROTOZOÁRIOS
unicelulares

Giardia
diarreia persistente, esteatorreia, creche
→ metronidazol 5–7 d · secnidazol/tinidazol DU

Entamoeba
disenteria, abscesso hepático
→ metronidazol 7–10 d + luminal

NEMATÓDEOS
vermes cilíndricos

Ascaris
bolo de vermes → suboclusão em criança
→ albendazol DU · suboclusão: CONSERVADOR + óleo mineral

Ancilóstomo
descalço → anemia ferropriva
→ albendazol DU + ferro

Strongyloides
corticoide → hiperinfecção + sepse gram –
→ IVERMECTINA

Enterobius
prurido anal noturno · fita adesiva
→ albendazol DU, repetir em 2 sem + família

CESTÓDEOS
vermes achatados (fita)

Taenia
come cisticerco (carne) → teníase
→ praziquantel DU

Cisticercose
come o OVO (T. solium) → neurocisticercose
→ neuroimagem; albendazol + corticoide

Parasita	Pista	Diagnóstico	Tratar
Enterobius (oxiúro)	**prurido anal noturno**, escoriações, criança, família	**fita adesiva (Graham)**	**albend mg DU em 2 s** tratar casa
Ascaris	dor, Löffler; **bolo de vermes → suboclusão em criança** (massa, vômitos biliosos, vermes pela boca)	EPF, RX	albend DU · **s CONS** (jejum hidrata **miner** depois falha/
Ancilostomídeos	descalço, **anemia ferropriva** (espoliação), geofagia	EPF	albend DU + f
Strongyloides	larva currens; **corticoide em dose alta → hiperinfecção: diarreia, lesões de pele, SEPSE por gram-negativo**/HTLV	Baermann-Moraes	**iverm µg/kg** albend 3 d
Giardia	diarreia persistente, **esteatorreia/má absorção**, creche	EPF seriado, Ag fecal	metro mg 8/ mg/kg secnid 2 g DU
Entamoeba	disenteria, abscesso hepático	EPF, sorologia, USG	metro 750 m d + lu
Taenia	**comeu CISTICERCO (carne crua) → TENÍASE**; **comeu o OVO (T. solium, fezes humanas) → CISTICERCOSE/neurocisticercose**	EPF/tamisação · neuroimagem	praziq mg/kg neuro albend cortic

- OMS: geo-helmintos > 20% → tratamento em massa 1×/ano; > 50% → 2×/ano (albendazol/mebendazol); não substitui saneamento e educação.

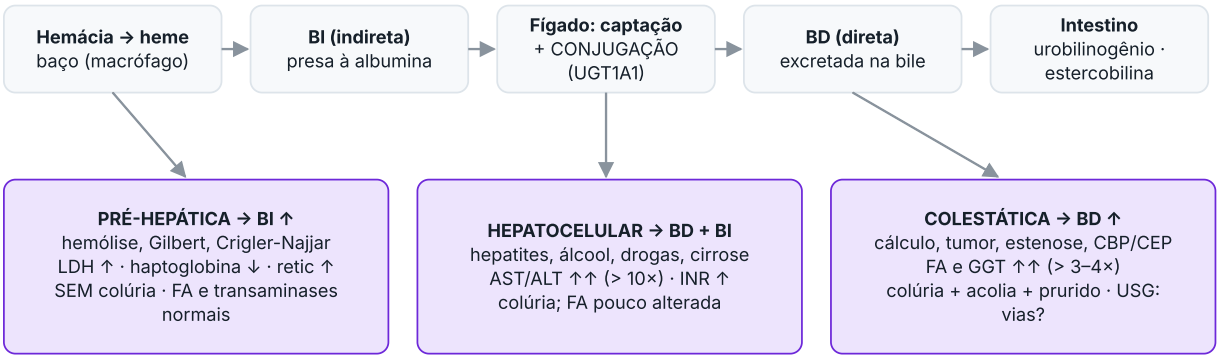
✎ *T11 discursiva 2: prurido anal noturno →* enterobíase · fita adesiva (Graham) · albendazol DU repetido em 2 semanas · tratar a família · unhas curtas, lavar mãos, roupas de cama em água quente. *Quem escreveu "albendazol 14 dias" perdeu o item. Diarreia de 20 dias =* persistente.

✕ *Seus erros na APF T12:* ***Strongyloides*** *(marcou Ancylostoma; pista = corticoide + sepse → ivermectina) ·* ***áscaris com suboclusão*** *(marcou laparotomia; é* conservador *— dica da Lou também) ·* ***teníase*** *×* ***cisticercose*** *(carne → tênia; ovo → cisticercose).*

SP3 · ICTERÍCIA, VIAS BILIARES E PÂNCREAS

ICTERÍCIA: TIPOS E CAUSAS

Bilirrubina: onde o fluxo trava define o tipo de icterícia



- Icterícia visível com BT > 2–3 mg/dL (escleras primeiro). Pergunta dos tutores: “se tem icterícia, quais doenças pode ter?” — responda pelos 3 grupos:

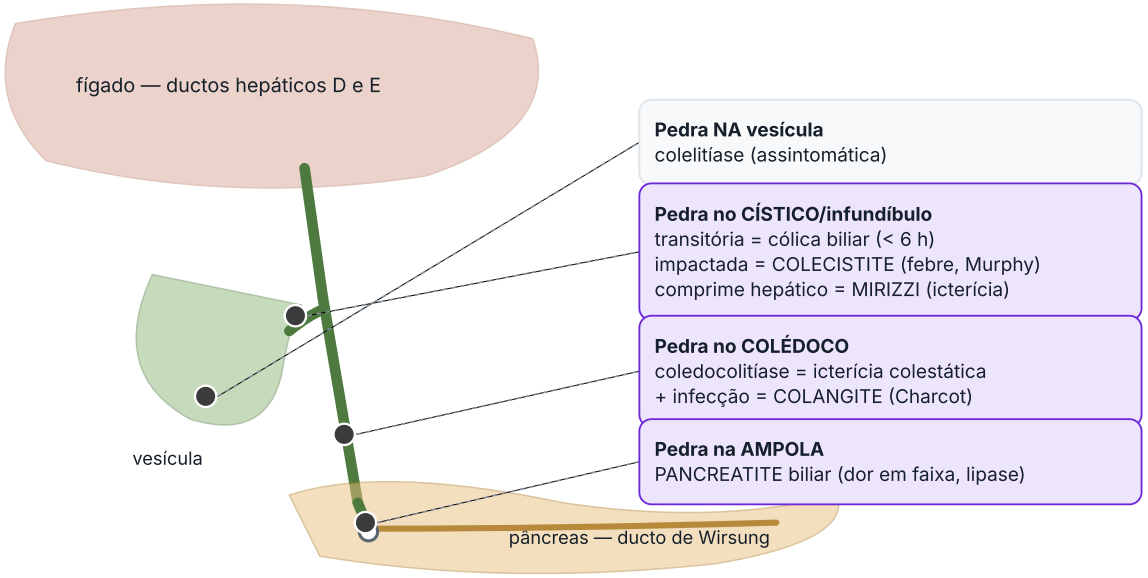
Tipo	Causas (cite 5)	Laboratório
Indireta (pré-hepática)	hemólise (esferocitose, falciforme, G6PD, autoimune), **Gilbert**, Crigler-Najjar, reabsorção de hematoma, eritropoese ineficaz, icterícia neonatal, rifampicina	BI ↑, LDH ↑, haptoglobina ↓, reticulócitos ↑; **sem colúria**; FA/transaminases normais
Hepatocelular	hepatites virais (A, B, C, E), alcoólica, medicamentosa (paracetamol), autoimune, cirrose, Wilson, isquêmica	**AST/ALT ↑↑ (> 10×)**, BD e BI, INR ↑, albumina ↓
Direta / colestática	coledocolitíase , tumor de cabeça de pâncreas/periampular, colangiocarcinoma, estenose biliar, Mirizzi, CEP/CBP, colestase da gravidez, drogas, Dubin-Johnson, Rotor	**BD ↑, FA e GGT ↑↑**, colúria, acolia, prurido; USG: vias dilatadas (extra-hepática)

- Causas de obstrução do colédoco: cálculo, tumor periampular/pâncreas, colangiocarcinoma, estenose benigna (pós-operatória, pancreatite crônica), Mirizzi, cisto de colédoco, parasita (áscaris), compressão por linfonodo.
- Função hepática (tutor): plaquetas, TAP/INR, albumina, bilirrubina, amônia — transaminases e FA são **lesão**, não função.
- Gilbert: jovem, icterícia leve após jejum/estresse/virose, só BI ↑, resto normal → benigno, não trata. **Courvoisier-Terrier**: vesícula palpável indolor + icterícia progressiva = tumor periampular (não cálculo).

✎ *T11 Q9:* indireta — hemólise; direta — coledocolitíase · *T9 discursiva 3:* cite 5 causas de BD e 5 de BI + 5 de obstrução do colédoco · *T11 discursiva 3: diga qual exame sobe em cada tipo (a corretora anotou isso).*

A ÁRVORE BILIAR: NÃO CONFUNDA AS DOENÇAS

Onde está a pedra define a doença



Doença	Dor	Febre	Icterícia	Lab / imag
Cólica biliar	HD/epigástrio pós-gordura, **< 6 h**, passa	não	não	normais · U cálculo
Colecistite aguda	HD > 6 h, **Murphy +**	sim	não/leve	leucocitos **USG: pare mm, líquid**
Coledocolitíase	cólica biliar	não	**sim, flutua**	BD, FA, GG colédoco >
Colangite	HD	**sim + calafrios**	sim	Charcot ± choque/co (Reynolds)
Pancreatite biliar	**epigástrio em faixa → dorso**	pode (SIRS)	às vezes	**lipase ≥ 3×** > 150
Mirizzi	de colecistite	±	sim	cálculo no infundíbulo comprimin hepático c
Tumor periampular	indolor/emagrecimento	não	**progressiva**	Courvoisie 19-9, TC

- Síndrome de Mirizzi: cálculo impactado no infundíbulo/cístico comprimindo o hepático comum → icterícia obstrutiva (APF T12). Cálculo que migrou e passou: icterícia e transaminases que sobem e caem sozinhas, colédoco normal (APF T12).

✎ Tutores: "SP3, cuidado para não confundir as doenças". *Erro nº 1 da turma:* colangite → colecistectomia *(T11 Q12 e discursiva). Colangite =* ***drenar a via (CPRE)****; colecistite =* ***tirar a vesícula****.*

CRITÉRIOS DE TÓQUIO (TG18)

Critérios de Tóquio (TG18)

suspeita e definitivo

	COLECISTITE		COLANGITE
A	LOCAL: Murphy · dor/massa/defesa no QSD	A	INFLAMAÇÃO: febre > 38 °C/calafrios · leucócitos < 4 ou > 10 mil · PCR ↑
B	SISTÊMICO: febre · PCR ↑ · leucocitose	B	COLESTASE: bilirrubina ≥ 2 · FA/GGT/AST/ALT > 1,5×
C	IMAGEM: USG (parede > 4 mm, líquido, Murphy US)	C	IMAGEM: dilatação biliar ou causa (cálculo, estenose, stent)
	Suspeita = A + B · Definitivo = A + B + C		**Suspeita = A + (B ou C) · Definitivo = A + B + C**

GRAU III (ambas) = disfunção de órgão: noradrenalina · confusão · PaO_2/FiO_2 < 300 · Cr > 2/oligúria · INR > 1,5 · plaquetas < 100 mil

colecistite → suporte + colecistostomia · colangite → suporte + ATB + DRENAGEM URGENTE (CPRE)

	Colecistite aguda	Colangite aguda
A	**Local**: Murphy; massa/dor/defesa em QSD	**Inflamação sistêmica**: febre > 38 °C/calafrios; leucócitos < 4 ou > 10 mil, PCR ≥ 1
B	**Sistêmico**: febre, PCR ↑, leucocitose	**Colestase**: icterícia (BT ≥ 2) ou FA/GGT/AST/ALT > 1,5× LSN
C	**Imagem** característica (USG)	**Imagem**: dilatação biliar ou etiologia (cálculo, estenose, stent)
Suspeita	A + B	1 de A + 1 de B ou C
Definitivo	A + B + C	A + B + C
Grau III	**disfunção orgânica**: hipotensão com vasopressor · rebaixamento de consciência · PaO_2/FiO_2 < 300 · oligúria/Cr > 2 · INR > 1,5 · plaquetas < 100 mil	
Grau II	leucócitos > 18 mil, massa palpável, > 72 h, inflamação local marcada (gangrenosa, enfisematosa, abscesso, peritonite biliar)	2 de: leuco > 12 mil ou < 4 mil, febre ≥ 39 °C, idade ≥ 75, BT ≥ 5, hipoalbuminemia
Conduta	I: VLP precoce · II: VLP precoce (centro experiente) ou drenagem · III: suporte + **colecistostomia percutânea**, cirurgia depois	I: ATB (drenar se não melhorar em 24 h) · II: ATB + **drenagem precoce** · III: ressuscitação + ATB + **drenagem urgente**

- Tríade de Charcot (dor em HD + febre + icterícia) + hipotensão + confusão = pêntade de Reynolds = colangite grave.

✎ *APF T12 (sua): febre + leucócitos + PCR + BT 4,3 + colédoco com cálculo =* colangite DEFINITIVA *(não precisa da tríade completa).*

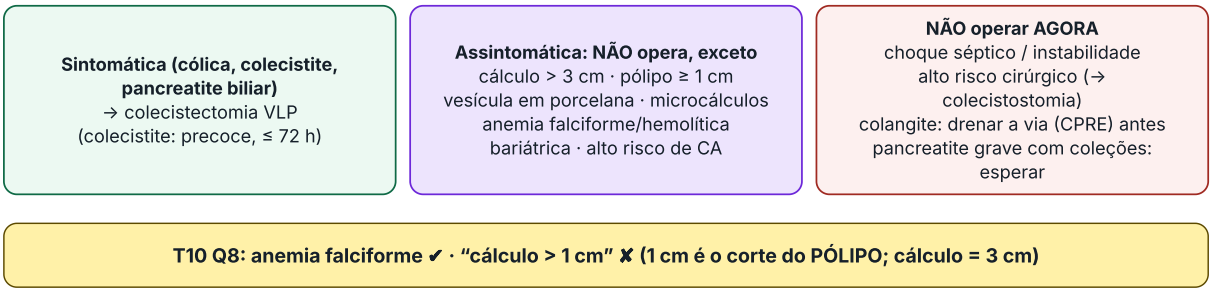
✕ *Sua APF T12: noradrenalina + confusão + Cr 2,5 + plaquetas 90 mil + cálculo no colédoco =* ***colangite grau III → suporte + drenagem biliar urgente*** *(você marcou colecistite grau III + colecistectomia — o mesmo erro da T11).*

✎ *T9 Q9 e T10 Q9: Charcot (± choque/confusão) →* colangite → ATB + drenagem da via biliar *· T11 Q12: Reynolds →* ATB amplo + CPRE urgente, tratamento definitivo da causa após estabilizar.

COLELITÍASE E COLECISTITE: CONDUTA

- Fatores de risco: mulher, > 40 a, obesidade, gestação/multiparidade, emagrecimento rápido, história familiar, hemólise (cálculo pigmentar). Assintomático: **não opera**, exceto as indicações abaixo.

Vesícula: quando operar e quando NÃO operar agora



T10 Q8: anemia falciforme ✔ · "cálculo > 1 cm" ✘ (1 cm é o corte do PÓLIPO; cálculo = 3 cm)

Ácido ursodesoxicólico (8–10 mg/kg/dia): só cálculo pequeno, radiotransparente, em quem não pode operar — dissolve em 6–24 meses

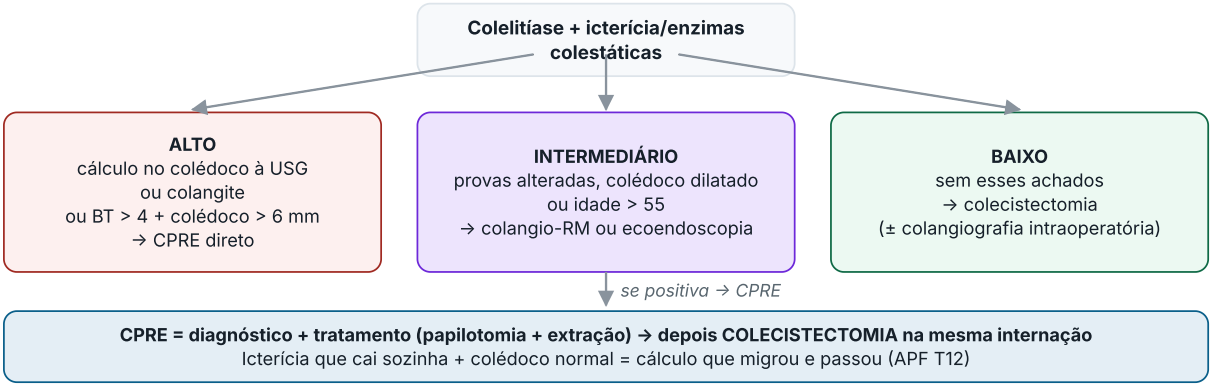
Acalculosa: paciente grave/UTI, jejum prolongado, nutrição parenteral · enfisematosa: idoso diabético (Clostridium)

- Colecistectomia no ASSINTOMÁTICO: anemia hemolítica (falciforme), **cálculo > 2,5–3 cm**, pólipo ≥ 1 cm (ou crescendo, > 50 a, com cálculo), vesícula em porcelana, microcálculos, anomalia da junção pancreatobiliar, alto risco de CA (indígenas, região endêmica), antes de transplante/bariátrica (considerar).
- NÃO operar agora (dica da Lou): choque séptico/instabilidade, alto risco cirúrgico (→ colecistostomia percutânea), colangite (drena a via antes), pancreatite grave com coleções; assintomático sem as indicações acima.
- Colecistite: USG = exame inicial e de escolha (cintilografia se dúvida). Hidratação + analgesia + ATB + colecistectomia VLP precoce na mesma internação (ideal ≤ 72 h, até 7–10 d). Alto risco cirúrgico/grau III: colecistostomia percutânea.

✎ *T10 Q8:* anemia falciforme *— quem marcou "cálculo > 1 cm" errou (1 cm é corte de **pólipo**) · APF: pólipo 2,3 cm aos 87 a →* colecistectomia *· T11 Q10:* VLP na mesma internação *· T11 Q11:* USG*.*

COLEDOCOLITÍASE: QUEM VAI DIRETO PARA CPRE

Suspeita de coledocolitíase: risco (ASGE) define o exame

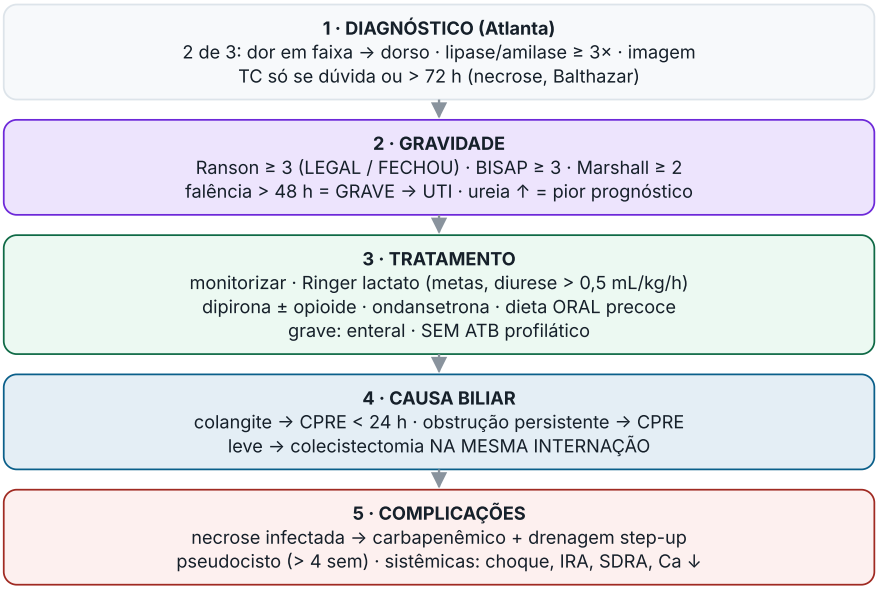


- Risco (ASGE): **alto** = cálculo no colédoco à USG, colangite, ou BT > 4 + colédoco dilatado (> 6 mm) → **CPRE** (diagnóstica e terapêutica: papilotomia + extração). **Intermediário** (provas alteradas, colédoco dilatado, > 55 a) → **colangio-RM ou ecoendoscopia** antes. Baixo → colecistectomia (± colangiografia intraoperatória).
- Conduta: internar · labs seriados (BT/frações, FA, GGT, TGO/TGP, INR, amilase/lipase, hemograma, PCR) · colangio-RM/eco-EDA se dúvida · CPRE · colecistectomia VLP na mesma internação. Complicações: colangite, pancreatite biliar, abscesso hepático, cirrose biliar secundária, coagulopatia.

✎ *T9 discursiva 3 (icterícia + colédoco 11 mm, "sem fator obstrutivo ao método"): a nota baixa foi de quem escreveu só "CPRE". Responda **regime (hospitalar) + exames + tratamento (CPRE + colecistectomia)**.*

PANCREATITE AGUDA

Pancreatite aguda: do diagnóstico à prevenção



- Causas: litíase biliar e álcool (~80%), hipertrigliceridemia (> 1.000), pós-CPRE, drogas, trauma, hipercalcemia, tumor. Biliar: cálculos + ALT > 150 + colestase + colédoco dilatado, sem álcool.
- Atlanta: 2 de 3 — dor típica (epigástrio em faixa → dorso), lipase/amilase ≥ 3× LSN, imagem característica. Lipase é mais específica e dura mais que a amilase. Enzimas NÃO medem gravidade.
- TC com contraste: melhor exame do pâncreas, mas NÃO na admissão — só se dúvida diagnóstica ou após 72–96 h (necrose, piora). USG na admissão = procurar cálculo (etiologia).
- **Gravidade**: Atlanta pela falência orgânica (Marshall ≥ 2 em respiratório, renal ou cardiovascular) — leve (sem falência/complicação) · moderadamente grave (falência < 48 h e/ou complicação local) · grave (falência **persistente > 48 h**). Ranson ≥ 3 = grave — admissão **LEGAL**: Leucócitos > 16 mil · Edade > 55 · Glicose > 200 · AST > 250 · LDH > 350; 48 h: queda de Ht > 10%, ↑ ureia > 5, Ca < 8, PaO_2 < 60, déficit de bases > 4, sequestro > 6 L. BISAP ≥ 3 (ureia/BUN, consciência, SIRS, idade > 60, derrame pleural), PCR > 150 em 48 h.
- Do tutor (vai cair): Ranson "LEGAL" na admissão e "FECHOU" em 48 h — **F**luido sequestrado > 6 L · **E**xcesso (déficit) de base > 4 · **C**álcio < 8 · **H**ematócrito cai > 10% · **O**$_2$ (PaO_2 < 60) · **U**reia sobe > 5. Mortalidade: 0–2 ≈ 1–5% · 3–4 ≈ 15–20% · 5–6 ≈ 40% · ≥ 7 muito alta. Ureia (BUN) alta = pior prognóstico · lipase NÃO tem relação com gravidade · Marshall = falência renal, cardiovascular e respiratória · Atlanta separa complicação local × sistêmica · TC de Balthazar após 48–72 h para necrose.

- Protocolo de tratamento: monitorização · jejum inicial · Ringer lactato · dipirona 1 g EV 6/6 h (± opioide) · ondansetrona 4 mg EV 8/8 h · profilaxia de TEV · controle glicêmico · diurese. Hidratação **moderada guiada por metas** (Ringer ~1,5 mL/kg/h; bolus 10 mL/kg se hipovolêmico — WATERFALL 2022); vigorosa importa nas primeiras 12–24 h. Dieta VO/enteral precoce (24–72 h) conforme tolerância — enteral, não parenteral. Resumo do tutor: "ressuscitação precoce e vigorosa com Ringer, 15–20 mL/kg e depois 250 mL/h, diurese > 0,5 mL/kg/h; jejum inicial → dieta leve precoce".

✕ *Sua APF T12: na leve, **dieta oral precoce conforme tolerância, pobre em gordura** (você marcou "jejum até normalizar a lipase"). A lipase não guia a realimentação.*

- ATB profilático: NÃO. Só se **necrose infectada** (gás, piora após 7–10 d) ou infecção extrapancreática → **carbapenêmico (meropenem 1 g 8/8 h)** + drenagem/necrosectomia em step-up (≥ 4 semanas).
- **Local**: Ranson ≥ 3 / falência / SIRS persistente → UTI. **CPRE**: urgente (< 24 h) se colangite; se obstrução persistente. **Colecistectomia**: na mesma internação (leve); grave com coleções → após resolução (~6 semanas).
- Complicações LOCAIS: coleção peripancreática aguda, **pseudocisto** (> 4 semanas, parede), necrose (estéril/**infectada**), walled-off necrosis, abscesso, trombose de v. esplênica/porta, pseudoaneurisma, ascite pancreática. SISTÊMICAS: SIRS/choque, **IRA**, **SDRA**/derrame pleural, CIVD, **hipocalcemia**, hiperglicemia, sepse, falência de múltiplos órgãos.

✎ *T9 Q7: falsas → "amilase mais específica que lipase", "parenteral precoce" (as vantagens são da ENTERAL), "RM é padrão-ouro" · T9 Q8: hidratação + monitorar órgãos (Marshall); ATB profilático, colecistectomia imediata e cirurgia de 1ª linha = erradas · T10 Q7: monitorização, jejum, Ringer, dipirona, ondansetrona.*

✎ *T10 discursiva 3: Ranson 4 → UTI (quem pôs enfermaria zerou) · complicações citadas como DM, esteatorreia e calcificação = **crônica**, não aguda.*

PANCREATITE CRÔNICA: COMO AVALIAR

Pancreatite crônica: como avaliar



Na AGUDA, DM/esteatorreia/calcificação não são complicações — são da CRÔNICA (erro da T10)

- Dica da Lou: como avaliar pancreatite crônica — TC ou RM = 1ª linha (calcificações, atrofia, Wirsung dilatado); **ecoendoscopia se dúvida**; CPRE não é diagnóstica; **ausência de calcificação não exclui**; função exócrina = elastase fecal; tutor: "achado = calcificação + ↓ vitamina K (má absorção de gordura)".

*✕ Sua APF T12: marcou "ecoendoscopia obrigatoriamente como primeiro exame" — certa era **TC ou RM como primeira linha**.*

HEPATITES E CIRROSE

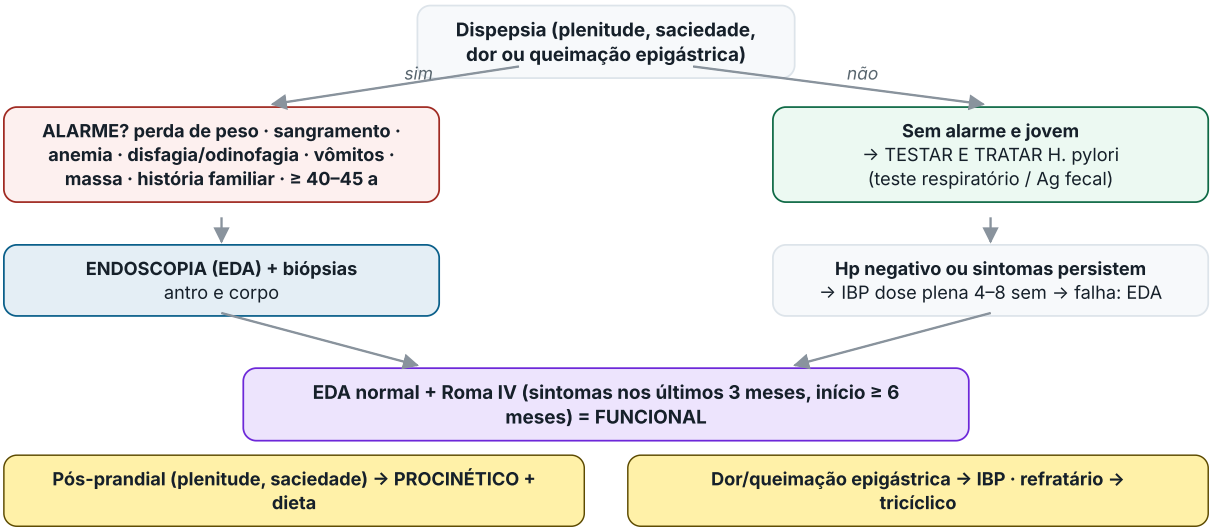
Perfil HBV	Interpretação
HBsAg + · anti-HBc IgM +	hepatite B **aguda**
HBsAg + · anti-HBc IgG + (> 6 m)	**crônica** (HBeAg + = replicação)
HBsAg – · anti-HBc + · anti-HBs +	infecção **passada, curada**
HBsAg – · anti-HBc – · anti-HBs +	**vacinado**
HBsAg – · anti-HBc + isolado	janela, oculta ou falso + → investigar (HBV-DNA)

- A e E: fecal-oral, agudas (E grave na gestante). C: parenteral, cronifica (~80%), tratamento com antivirais de ação direta. Cirrose: ascite (PBE: PMN > 250 → ceftriaxona/cefotaxima + albumina), varizes, encefalopatia, Child-Pugh/MELD.

SP4 · DISPEPSIA, DRGE, ÚLCERA E HDA

DISPEPSIA E SINAIS DE ALARME

Dispepsia: alarme → EDA; sem alarme → testar e tratar



- Quando o Roma IV define dispepsia FUNCIONAL (dica da Lou): ≥ 1 sintoma (plenitude pós-prandial, saciedade precoce, dor ou queimação epigástrica) + sem doença estrutural que explique (EDA normal) + presentes nos últimos 3 meses com início ≥ 6 meses antes. Subtipos: desconforto pós-prandial (≥ 3 d/sem) e dor epigástrica (≥ 1 d/sem).
- Roma IV: plenitude pós-prandial, saciedade precoce, dor ou queimação epigástrica. Funcional = sem doença estrutural (EDA normal) que explique; mecanismos: esvaziamento lento, falha de acomodação do fundo, hipersensibilidade visceral, inflamação duodenal, eixo cérebro-intestino.
- Alarme → EDA: perda de peso, sangramento (hematêmese, "borra de café", melena), anemia, disfagia/odinofagia, vômitos persistentes, massa, linfonodo, história familiar de CA gástrico, início ≥ 40–45 a (Brasil).
- Sem alarme e jovem: **test-and-treat H. pylori** (até 45 a) ou IBP empírico.
- Dispepsia funcional — tratamento pelo subtipo: plenitude/saciedade (desconforto pós-prandial) → PROCINÉTICO + dieta · dor/queimação epigástrica → IBP 4–8 sem; H. pylori + → erradicar; refratário → antidepressivo tricíclico em dose baixa.

✎ *T11 Q13: plenitude + distensão, EDA e Hp negativos →* procinético + medidas dietéticas *(IBP era o distrator) · T10 Q11:* motilidade + hipersensibilidade visceral *· T9 Q11:* perda de 5 kg → EDA *· APF: alarme =* vômito em borra de café.

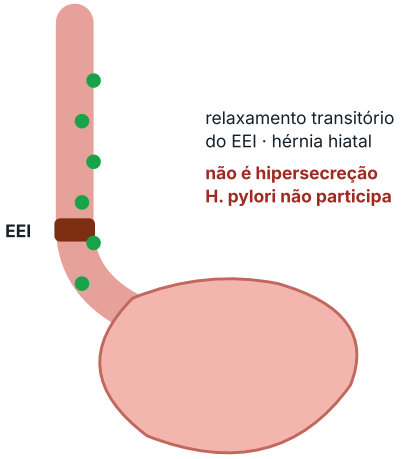
FISIOPATOLOGIA DAS DOENÇAS DISPÉPTICAS

- TUTORA 20/10 Base: equilíbrio AGRESSÃO × DEFESA da mucosa. Agressores: ácido (HCl), pepsina, **H. pylori**, **AINE/AAS**, bile, álcool, tabaco, isquemia (estresse). Defesa: muco + bicarbonato, **prostaglandinas** (COX-1), fluxo sanguíneo, junções firmes, renovação epitelial.
- Secreção ácida: célula parietal (H^+/K^+-ATPase) estimulada por **gastrina** (célula G do antro), **histamina** (célula ECL → receptor H2) e **acetilcolina** (vago, M3); **somatostatina** (célula D) freia. IBP bloqueia a bomba de forma irreversível e só age na bomba ATIVA → tomar 30–60 min antes do café.

Doença	Mecanismo central	Consequência
Dispepsia funcional	**sem lesão estrutural**: esvaziamento gástrico lento, falha da acomodação do fundo, **hipersensibilidade visceral**, microinflamação duodenal (eosinófilos), eixo cérebro-intestino, pós-infecciosa	plenitude/saciedade (motilidade → procinético) · dor/queimação (sensibilidade/ácido → IBP); EDA normal
DRGE	**falha da BARREIRA antirrefluxo**: relaxamentos transitórios do EEI (principal), EEI hipotônico, hérnia hiatal, depuração esofágica ruim, ↑ pressão abdominal (obesidade, gestação)	ácido no esôfago → pirose/esofagite → Barrett; **não é hipersecreção**; **H. pylori não participa**
Gastrite por H. pylori (antral)	urease → amônia (protege do ácido e lesa), flagelos, CagA/VacA; infecção do antro destrói células D → **↓ somatostatina → ↑ gastrina → hipercloridria**	metaplasia gástrica no duodeno → colonização → **úlcera DUODENAL**
Pangastrite / gastrite atrófica (corpo)	H. pylori no corpo ou autoimune → perda de células parietais → **hipocloridria**	**úlcera GÁSTRICA**, metaplasia intestinal → adenocarcinoma (cascata de Correa), linfoma MALT; autoimune → B12 ↓
Úlcera por AINE/AAS	inibição da **COX-1** → ↓ prostaglandinas → ↓ muco, bicarbonato, fluxo e reparo + lesão tópica direta	úlcera **gástrica** (antro), muitas vezes silenciosa → abre com sangramento/perfuração
Úlcera duodenal × gástrica	duodenal = **agressão ↑** (ácido, H. pylori antral) · gástrica = **defesa ↓** (AINE, atrofia)	DU: dor que **melhora** com a comida, piora 2–3 h depois/madrugada · GU: **piora** com a comida, emagrece
Zollinger-Ellison	gastrinoma → gastrina muito alta → hipersecreção	úlceras múltiplas/atípicas (jejuno), diarreia, refratárias
Lesão aguda de mucosa (estresse)	isquemia da mucosa em choque, queimado, TCE, VM	erosões e HDA no paciente de UTI → profilaxia com IBP

DRGE

DRGE: IBP primeiro; exame para quem não responde



Pirose + regurgitação, sem alarme
→ IBP dose plena 4–8 sem + medidas (peso, cabeceira, não deitar após comer)

Alarme, refratário, idade, longa duração (Barrett) → EDA

EDA normal + sintomas → pHmetria 24 h / pH-impedância SEM IBP (7 dias)
= padrão-ouro para provar o refluxo

Manometria: antes da fundoplicatura (afasta acalasia) — NÃO diagnostica DRGE

Dor torácica em queimação + ECG/troponina normais → IBP

- Mecanismo principal: relaxamentos transitórios do EEI (+ EEI hipotônico, hérnia hiatal, depuração ruim, esvaziamento lento). Obesidade, gordura, álcool, refrigerante, tabaco, deitar após comer pioram. H. pylori NÃO está relacionado à fisiopatologia da DRGE (dica da Lou; erradicar não piora o refluxo).
- Típica: pirose + regurgitação, pós-prandial e ao deitar. Atípicas: tosse, rouquidão, asma, dor torácica não cardíaca (afastar SCA primeiro).
- Sem alarme → IBP dose plena 4–8 semanas como teste terapêutico + medidas (perder peso, elevar a cabeceira, não deitar 2–3 h após comer). EDA: alarme, refratário, ≥ 40–45 a, longa duração (Barrett). pHmetria 24 h (padrão-ouro) com IBP suspenso ~7 dias: sintomas que voltam após suspender/atípicos/antes de cirurgia. Manometria: antes de fundoplicatura (afastar acalasia) — não para diagnosticar DRGE. Interpretação dos exames em Exames: como interpretar.
- Barrett: metaplasia intestinal → vigilância endoscópica; complicações: esofagite, estenose, Barrett, adenocarcinoma.

✎ *T9 Q10:* relaxamento transitório do EEI · *T9 Q12: dor torácica em queimação, ECG/troponina normais →* IBP · *T11 Q14: pirose sem alarme →* IBP 4–8 sem · *T10 Q10: volta após suspender →* pHmetria após 7 dias sem IBP · *APF T12:* RTEEI + hérnia hiatal; IBP antes da refeição + medidas *(× hipersecreção, × manometria inicial) e refratário sem DRGE comprovada →* pHmetria/pH-impedância SEM IBP.

ÚLCERA PÉPTICA

Úlcera duodenal × gástrica

DUODENAL	GÁSTRICA
H. pylori + hipersecreção ácida	AINE + H. pylori · ácido normal/baixo
dor MELHORA com a comida	dor PIORA com a comida · emagrece
volta 2–3 h depois · acorda de madrugada	pode ser CÂNCER → biopsiar sempre
não maligniza	suspeita (bordas elevadas): aguardar histopatológico
controle: teste respiratório (sem nova EDA)	controle: EDA com biópsia em 8–12 sem
IBP 4 semanas	IBP 8 semanas

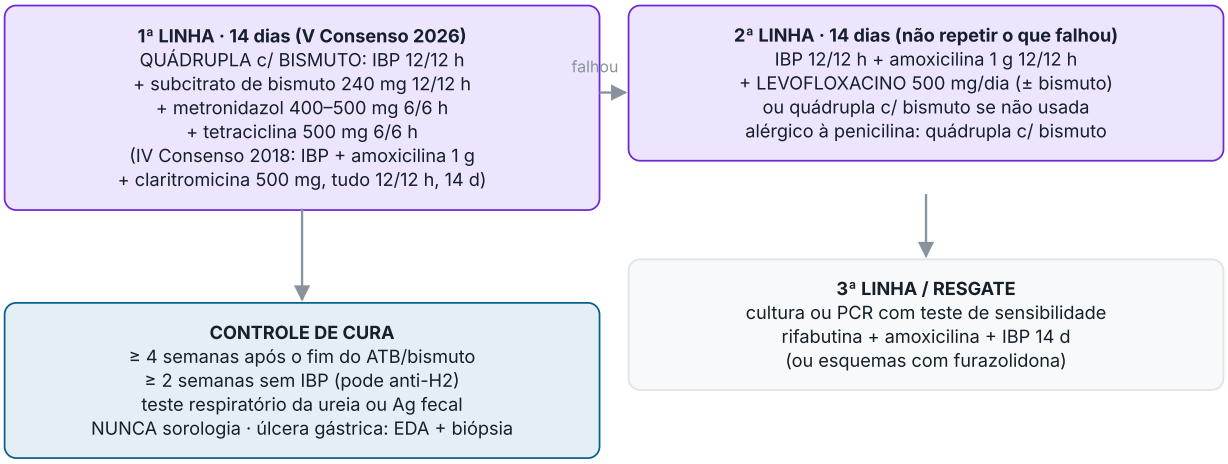
AINE inibe COX → ↓ prostaglandina → ↓ muco, bicarbonato, fluxo e reparo da mucosa

- Tratamento (início, dose, indicação): suspender AINE/AAS, álcool e tabaco · **erradicar H. pylori se positivo** (toda úlcera infectada) · IBP dose plena: omeprazol 20 mg ou pantoprazol 40 mg 1×/dia em jejum — duodenal 4 sem (até 8), gástrica 8 sem (até 12) · AINE indispensável → IBP contínuo ou coxibe + IBP.
- Úlcera gástrica de aspecto suspeito (bordas elevadas, fundo irregular, perda de peso): aguardar histopatológico; benigna → IBP (± sucralfato) e EDA de controle; maligna → estadiar/gastrectomia.
- Complicações: hemorragia (a mais comum), perfuração, penetração (pâncreas), obstrução/estenose pilórica (vômitos, alcalose hipoclorêmica hipocalêmica) — e anemia ferropriva.

✎ *T10 Q12:* duodenal = hipersecreção + H. pylori; gástrica = também AINE *(a errada invertia "melhora/piora com a comida") · T11 Q15:* aguardar histopatológico · *APF: AINE →* úlcera/sangramento · *APF T12:* AINE inibe COX → ↓ prostaglandinas → ↓ muco, bicarbonato, fluxo e reparo *; quádrupla com bismuto 14 d = opção recomendada; perfuração = ressuscitação + jejum + ATB + cirurgia.*

H. PYLORI: DIAGNÓSTICO, LINHAS E CONTROLE

H. pylori: 1ª → 2ª → 3ª linha → controle de cura



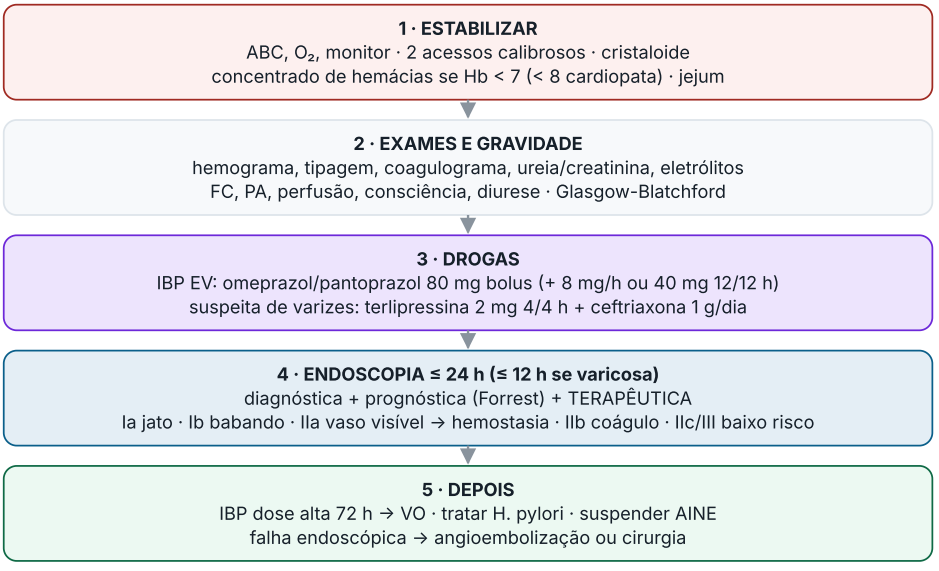
- TUTORA 20/10 Exames do H. pylori — testes: invasivos (EDA) — **urease na biópsia**, histologia, cultura/PCR (sensibilidade); não invasivos — **teste respiratório com ureia marcada** (melhor), **antígeno fecal**, sorologia (só contato prévio; **nunca para controle**). **Suspender IBP 14 dias e ATB/bismuto 4 semanas** antes do teste (falso-negativo).
- 1ª linha (V Consenso Brasileiro 2026): quádrupla com bismuto, 14 dias — IBP 12/12 h (ou vonoprazana 20 mg 12/12 h) + subcitrato de bismuto 240 mg 12/12 h + metronidazol 400–500 mg 6/6 h + tetraciclina 500 mg 6/6 h. Ainda muito cobrada (IV Consenso 2018): tríplice — IBP 12/12 h + amoxicilina 1 g 12/12 h + claritromicina 500 mg 12/12 h por 14 dias. Na T11 a tutora aceitou as duas.
- 2ª linha (14 dias; nunca repetir o que falhou): IBP 12/12 h + amoxicilina 1 g 12/12 h + **levofloxacino 500 mg 1×/dia** (± bismuto), ou quádrupla com bismuto se ainda não usada.
- 3ª linha / resgate: guiada por **cultura/PCR com teste de sensibilidade**; rifabutina + amoxicilina + IBP 14 d (ou esquemas com furazolidona). **Alérgico à penicilina**: quádrupla com bismuto.
- Orientar: metronidazol = gosto metálico e efeito antabuse (sem álcool) · bismuto = **fezes pretas (não é melena)** · tetraciclina não em gestante/< 8 a, longe de leite/antiácido · claritromicina = interações (CYP3A4).
- Controle de cura: teste respiratório (ou Ag fecal) ≥ 4 semanas após o fim do tratamento e ≥ 2 semanas sem IBP; nunca sorologia; úlcera gástrica → EDA com biópsia.

✎ *APF T12:* teste respiratório ou Ag fecal ≥ 4 semanas após ATB/bismuto, IBP suspenso ~2 semanas *(× melhora dos sintomas, × sorologia, × "mantendo o omeprazol").*

✎ *T11 Q16:* teste respiratório ≥ 4 semanas após o término · *T11 discursiva 4:* úlcera duodenal + urease + — tratamento com DROGA + DOSE + INTERVALO + DURAÇÃO, IBP até cicatrizar, ferro; seguimento com teste em 4 semanas; complicações.

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA

Hemorragia digestiva alta: a ordem do manejo



- HDA = acima do ângulo de Treitz: hematêmese, "borra de café", **melena** (ureia ↑ desproporcional à creatinina). Não varicosa: úlcera péptica (principal — AINE/H. pylori), gastrite erosiva, Mallory-Weiss, esofagite, neoplasia, Dieulafoy · Varicosa: varizes esofagogástricas (etilista/cirrose). Diagnósticos diferenciais (dica da Lou): úlcera péptica, varizes, Mallory-Weiss, esofagite/gastrite erosiva, câncer, Dieulafoy, angiodisplasia, fístula aortoentérica, hemobilia; e "falsa HDA": epistaxe deglutida, hemoptise, ferro/bismuto escurecendo as fezes.
- Gravidade: FC, PA (hipotensão postural), índice de choque, perfusão (TEC, extremidades frias), consciência, diurese, volume do sangramento; escores **Glasgow-Blatchford** (pré-EDA; ≤ 1 = alta) e Rockall.
- TUTORA 20/10 Laboratório na HDA não varicosa: Hb inicial pode estar NORMAL (cai após hidratação, 24–72 h) · ureia ↑ com creatinina normal (sangue digerido = sangramento alto) · plaquetas e INR (anticoagulante, hepatopatia) · tipagem + prova cruzada · lactato · Glasgow-Blatchford usa ureia, Hb, PAS, FC, melena, síncope, hepatopatia e IC.

- Protocolo emergencial: ABC · O_2 · monitor · 2 acessos calibrosos · cristaloide · transfusão restritiva (Hb < 7; < 8 se cardiopata) · jejum · labs (hemograma, tipagem/prova cruzada, coagulograma, ureia/creatinina, eletrólitos, função hepática, lactato) · IBP EV: omeprazol/pantoprazol 80 mg em bolus (+ 8 mg/h ou 40 mg 12/12 h) · eritromicina 250 mg EV pré-EDA · **suspeita de varizes: terlipressina 2 mg EV 4/4 h (ou octreotide) + ceftriaxona 1 g/dia** · suspender AINE.

- EDA: diagnóstica + prognóstica (Forrest) + TERAPÊUTICA, em até 24 h após estabilizar (≤ 12 h se varicosa ou alto risco). Forrest Ia (jato) / Ib (babando) / IIa (vaso visível) → tratar (adrenalina + térmico/clipe); IIb (coágulo) → remover e avaliar; IIc/III → baixo risco. Varizes → ligadura elástica.
- Após hemostasia de alto risco: IBP dose alta 72 h → VO 2×/dia até 14 d → 1×/dia. Pesquisar e tratar H. pylori.

✎ ***Discursiva de HDA caiu na T9 e na T10*** *(etilista + AINE, hematêmese, choque): causas (varicosa × não varicosa), abordagem/estabilização, gravidade,* papel e momento da EDA — sempre escrever a finalidade TERAPÊUTICA *(a corretora anotou "+ tratamento" nas duas).*

PROTOCOLOS E DOSES (O QUE OS TUTORES PEDIRAM)

PRESCRIÇÃO: CLASSES E DOSES

- TUTORA 20/10 Revisar doses e prescrição de analgésicos, antieméticos, procinéticos, IBP e antibióticos. Toda linha da prescrição tem **droga + dose + via + intervalo** (+ duração/"se necessário"). Ordem: **1 dieta · 2 hidratação · 3 analgesia · 4 antiemético · 5 protetor gástrico · 6 ATB · 7 profilaxia de TEV · 8 sintomáticos SN · 9 cuidados** (sinais vitais, diurese, SNG, glicemia) · **exames**.

Classe	Droga · dose adulto	Criança / cuidados
Analgésico simples	**dipirona 1 g EV/VO 6/6 h** (até 4 g/d) · **paracetamol 500 mg–1 g VO 6/6 h** (máx 4 g; 2 g em hepatopata/etilista)	dipirona 15–25 mg/kg/dose 6/6 h · paracetamol 10–15 mg/kg/dose 6/6 h
Antiespasmódico	**escopolamina (butilbrometo) 20 mg EV 8/8 h** (± dipirona) — cólica biliar/renal/intestinal	evitar em obstrução/ íleo, glaucoma, retenção urinária
AINE	cetoprofeno 100 mg EV 12/12 h · diclofenaco 75 mg IM — cólica renal/biliar	**não** em úlcera/HDA, IRA, desidratação, gestante 3º tri
Opioide	**tramadol 50–100 mg EV 6/6 h** (máx 400 mg/d) · **morfina 2–4 mg EV** (0,05–0,1 mg/kg) até 4/4 h na dor intensa	analgesia **não mascara** o diagnóstico do abdome agudo — não deixar sem; morfina: depressão respiratória → naloxona
Antiemético	**ondansetrona 4–8 mg EV/VO 8/8 h** (anti-5-HT3) · **metoclopramida 10 mg EV/VO 8/8 h** · **bromoprida 10 mg EV/VO 8/8 h** · dimenidrinato 50 mg EV 6/6 h (vertigem/cinetose)	ondansetrona 0,15 mg/kg (dose única ajuda a TRO) · QT longo · **metoclopramida proibida < 1 ano**, extrapiramidal
Procinético	**metoclopramida 10 mg** (anti-D2 central + 5-HT4) · **domperidona 10 mg VO 8/8 h** (anti-D2 periférico, não cruza a BHE) · bromoprida 10 mg — 15–30 min antes das refeições, curto prazo (≤ 5 d a metoclopramida)	**contraindicados** em obstrução mecânica, perfuração e HDA · indicação: dispepsia com plenitude, gastroparesia, refluxo com vômito
IBP	VO em jejum: **omeprazol 20 · pantoprazol 40 · esomeprazol 40 · lansoprazol 30 · rabeprazol 20 mg** 1×/d · EV: omeprazol/pantoprazol **40 mg 1–2×/d** · HDA: **80 mg bolus + 8 mg/h**	omeprazol ~1 mg/kg/d · uso longo: ↓ B12, Mg, ferro, fratura, C. difficile · anti-H2: famotidina 20 mg 12/12 h · sucralfato 1 g 6/6 h
ATB intra-abdominal	**ceftriaxona 1–2 g EV 1×/d + metronidazol 500 mg EV 8/8 h** · grave: **pip-tazo 4,5 g 6/6 h** ou **meropenem 1 g 8/8 h** · profilaxia cirúrgica: **cefazolina 2 g** na indução · amoxi-clav 875/125 mg 12/12 h VO	ceftriaxona 50–100 mg/kg/d · metronidazol 30 mg/kg/d
ATB na diarreia	adulto: **cipro 500 mg 12/12 h 3 d** ou **azitromicina 500 mg/d 3 d** (ou 1 g DU) · C. difficile: **vancomicina 125 mg VO 6/6 h 10 d** · giárdia/ameba: metronidazol	criança: azitromicina 10 mg/kg D1 + 5 mg/kg D2–5 · ceftriaxona 50 mg/kg
ATB do H. pylori	amoxicilina 1 g 12/12 h · claritromicina 500 mg 12/12 h · metronidazol 400–500 mg · tetraciclina 500 mg 6/6 h · bismuto 240 mg · levofloxacino 500 mg/d — sempre **14 dias** + IBP 12/12 h	ver tabela de linhas
Varizes (HDA varicosa)	terlipressina 2 mg EV 4/4 h · ceftriaxona 1 g/d 7 d	—
Profilaxia de TEV	**enoxaparina 40 mg SC 1×/d** (ou heparina 5.000 UI SC 8/8 h)	não na HDA ativa
Antidiarreico	loperamida 4 mg + 2 mg após cada evacuação (máx 16 mg/d) — adulto sem febre/sangue	**contraindicada em criança e disenteria** · zinco na criança

Modelo — 1ª prescrição de abdome agudo inflamatório (adulto 70 kg)

1. Dieta zero · 2. SF 0,9% 1.000 mL EV 8/8 h (ou Ringer) · 3. Dipirona 1 g EV 6/6 h + tramadol 100 mg EV 8/8 h SN dor intensa · 4. Ondansetrona 4 mg EV 8/8 h SN náusea · 5. Omeprazol 40 mg EV 1×/d (se jejum/estresse) · 6. Ceftriaxona 2 g EV 1×/d + metronidazol 500 mg EV 8/8 h · 7. Enoxaparina 40 mg SC 1×/d · 8. SSVV 6/6 h, diurese, cabeceira 30° · Exames: hemograma, PCR, eletrólitos, ureia/creatinina, lipase, bilirrubinas/FA/GGT/TGO/TGP, EAS, β-HCG, coagulograma, tipagem

IBP · ÚLCERA · H. PYLORI · HDA

Situação	Droga · dose · intervalo · tempo
IBP dose padrão (plena)	**omeprazol 20 mg · pantoprazol 40 mg** · lansoprazol 30 · esomeprazol 40 · rabeprazol 20 mg — 1×/dia, 30–60 min antes do café
Dose dobrada	a mesma dose 12/12 h: erradicação de H. pylori, DRGE refratária
DRGE / dispepsia (dor)	IBP dose plena 4–8 semanas, depois menor dose eficaz/sob demanda
Úlcera duodenal	erradicar Hp + IBP dose plena **4 semanas** (até 8)
Úlcera gástrica	erradicar Hp + IBP **8 semanas** (até 12) + EDA com biópsia em 8–12 sem
H. pylori 1ª linha	**Quádrupla c/ bismuto 14 d**: IBP 12/12 + bismuto 240 mg 12/12 + metronidazol 400–500 mg 6/6 + tetraciclina 500 mg 6/6 · ou **tríplice 14 d**: IBP 12/12 + amoxicilina 1 g 12/12 + claritromicina 500 mg 12/12
H. pylori 2ª linha	IBP 12/12 + amoxicilina 1 g 12/12 + **levofloxacino 500 mg/dia** (± bismuto) 14 d · ou quádrupla c/ bismuto
H. pylori 3ª linha	teste de sensibilidade (cultura/PCR) · rifabutina + amoxicilina + IBP 14 d
Controle de cura	teste respiratório/Ag fecal ≥ 4 sem após o fim · ≥ 2 sem sem IBP
HDA	**omeprazol/pantoprazol 80 mg EV bolus** + 8 mg/h (ou 40 mg EV 12/12 h) 72 h · varizes: terlipressina 2 mg 4/4 h + ceftriaxona 1 g/dia
Dispepsia funcional c/ plenitude	procinético: domperidona 10 mg 8/8 h ou metoclopramida 10 mg 8/8 h, 15–30 min antes das refeições, curto prazo

ABDOME AGUDO · VESÍCULA · PÂNCREAS

Quadro	Protocolo
Obstrução intestinal	jejum · **SNG aberta** · SF/Ringer + KCl conforme K · dipirona 1 g EV 6/6 h · ondansetrona 4–8 mg 8/8 h · sonda vesical · lactato/gaso · RX → TC · cirurgia se sofrimento ou falha em 48–72 h
Pancreatite aguda	monitorização · jejum inicial → VO em 24–72 h · **Ringer lactato** (metas) · dipirona 1 g 6/6 h ± morfina/tramadol · ondansetrona 4 mg 8/8 h · enoxaparina 40 mg SC · **sem ATB profilático** · UTI se grave · CPRE se colangite · colecistectomia na internação
Necrose infectada	**meropenem 1 g EV 8/8 h** (ou imipenem) + drenagem step-up
Colecistite	jejum, hidratação, analgesia · **ceftriaxona 1–2 g/dia + metronidazol 500 mg 8/8 h** · colecistectomia VLP precoce (≤ 72 h) · grave/alto risco: colecistostomia
Colangite	ressuscitação · ceftriaxona + metronidazol (grave: **pip-tazo 4,5 g 6/6 h** ou meropenem) · **drenagem por CPRE** (urgente no grau III) · colecistectomia depois
Apendicite	apendicectomia VLP + cefazolina 2 g (ou ceftriaxona + metronidazol); complicada: ATB 4–7 d
Diverticulite não complicada	dieta líquida, analgesia · amoxi-clav 875/125 12/12 h ou cipro 500 12/12 + metronidazol 500 8/8 h, 7–10 d · colonoscopia em 6–8 sem
Isquemia mesentérica	angio-TC · **heparina não fracionada plena** · ATB · revascularização · laparotomia se peritonite

DIARREIA · HIDRATAÇÃO · PARASITOSES

Quadro	Protocolo
Plano A	SRO após cada evacuação: < 1 a 50–100 mL · 1–10 a 100–200 mL · > 10 a à vontade · zinco 10 mg (< 6 m) / 20 mg (≥ 6 m) 10–14 d · alimentação habitual · sinais de retorno
Plano B	SRO 50–100 mL/kg em 4–6 h na unidade · vômitos: gastróclise 20–30 mL/kg/h · reavaliar
Plano C	SF 0,9%/Ringer · **cartaz 2023**: < 1 a 30 mL/kg em 1 h + 70 mL/kg em 5 h · ≥ 1 a 30 mL/kg em 30 min + 70 mL/kg em 2h30 · **cartaz antigo (APF T12)**: < 5 a 20 mL/kg em 30 min, repetir · SRO 5 mL/kg/h quando beber
Disenteria grave (criança)	**azitromicina** 10 mg/kg D1 + 5 mg/kg/d D2–5 (2023) · ou ciprofloxacino 15 mg/kg 12/12 h 3 d (antigo) · ceftriaxona 50–100 mg/kg/d se internada · **sem loperamida**
Oxiúro / Ascaris / ancilóstomo	albendazol 400 mg DU (oxiúro: repetir em 2 sem + família) · mebendazol 100 mg 12/12 h 3 d
Strongyloides	ivermectina 200 µg/kg DU (1–2 d) · albendazol 400 mg 3 d
Giardia	metronidazol 250 mg 8/8 h 5–7 d (criança 15 mg/kg/d) · secnidazol/tinidazol 2 g DU
Amebíase invasiva	metronidazol 500–750 mg 8/8 h 7–10 d + amebicida luminal (teclozana)
Teníase	praziquantel 5–10 mg/kg DU · albendazol 400 mg 3 d
Celíaca	dieta isenta de glúten para sempre + ferro/folato/vitaminas/cálcio

EXAMES: INDICAÇÃO E COMO SÃO FEITOS

Exame	Como é feito	Quando pedir
RX de abdome agudo	tórax PA em pé + abdome em pé + deitado	exame INICIAL: pneumoperitônio, obstrução (escada), volvo
USG de abdome	transdutor, sem radiação, jejum 6–8 h para vesícula	vesícula/colecistite (escolha), vias biliares dilatadas, criança/gestante, FAST no trauma/hemorrágico
TC com contraste	contraste IV (± oral); cuidado com função renal	diverticulite, obstrução (ponto de transição), complicações; pancreatite só se dúvida/> 72 h
Angio-TC	contraste IV em fase arterial	isquemia mesentérica
Colangio-RM	RM sem contraste iodado, não invasiva	coledocolitíase de risco intermediário, anatomia biliar, pancreatite crônica
Ecoendoscopia	endoscópio com transdutor no duodeno (sedação)	microcálculos/coledocolitíase intermediária, pancreatite crônica duvidosa, tumores
CPRE	duodenoscópio + cateter na papila + contraste; papilotomia	TERAPÊUTICA: coledocolitíase de alto risco, colangite (drenagem). Risco: pancreatite pós-CPRE
Cintilografia (HIDA)	radiofármaco excretado na bile; vesícula não enche = cístico obstruído	colecistite com USG duvidoso
EDA	endoscópio pela boca, sedação, jejum; biópsias (Hp: antro + corpo)	dispepsia com alarme/idade, HDA (≤ 24 h), úlcera gástrica (controle), celíaca (biópsia duodenal), DRGE refratária
pHmetria 24 h	cateter nasal até 5 cm acima do EEI (ou cápsula); **IBP suspenso ~7 dias**	provar DRGE: refratário, atípico, antes de cirurgia (padrão-ouro)
pH-impedanciometria	cateter com sensores de impedância + pH	refluxo ácido e NÃO ácido; sintomas em uso de IBP
Manometria esofágica	cateter de pressão; paciente engole água	antes da fundoplicatura (afastar acalasia/hipomotilidade); NÃO diagnostica DRGE
Teste respiratório da ureia	bebe ureia com ^{13}C; urease do Hp libera CO_2 marcado no ar	diagnóstico e CONTROLE DE CURA do Hp (≥ 4 sem pós-ATB, 2 sem sem IBP)
Antígeno fecal	amostra de fezes (monoclonal)	diagnóstico e controle de cura do Hp; bom em criança
Teste da urease (biópsia)	fragmento na EDA em meio com ureia; muda de cor	Hp em quem já está fazendo EDA
Sorologia Hp	IgG no sangue	só contato prévio; **nunca** controle de cura
Anti-tTG IgA + IgA total	sangue, **com glúten** na dieta	rastreio de doença celíaca → confirmar com biópsia duodenal
Teste do H_2 expirado	ingere lactose; mede H_2 no ar	intolerância à lactose
Fita adesiva (Graham)	fita na região perianal pela manhã, antes do banho	enterobíase
Elastase fecal	amostra de fezes	insuficiência pancreática exócrina (pancreatite crônica)
RM de abdome	sem radiação, sem iodo; demorada, cara	gestante (apendicite com USG duvidoso), lesões hepáticas/pancreáticas, alergia a iodo
Esofagograma baritado	bebe bário + RX seriado	disfagia, acalasia ("bico de pássaro"), estenose, hérnia hiatal

EXAMES: COMO INTERPRETAR

- TUTORA 20/10 Solicitação e interpretação de US, TC, RM, colangio-RM, EDA, pH-impedanciometria e manometria .

Exame	Achados que a prova cobra
RX abdome agudo	**pneumoperitônio** (ar sob as cúpulas, Rigler = parede da alça visível dos dois lados) · **delgado**: alças centrais > 3 cm, pregas coniventes (“pilha de moedas”), níveis hidroaéreos em escada · **cólon**: periférico, haustrações, > 6 cm (ceco > 9 cm = risco de perfuração) · volvo de sigmoide: “grão de café”/U invertido · **íleo biliar**: obstrução + aerobilia + cálculo ectópico (tríade de Rigler)
USG	**cálculo** = imagem hiperecogênica com **sombra acústica posterior**, móvel · **colecistite**: parede > 4 mm (dupla camada), líquido pericolecístico, cálculo impactado no infundíbulo, Murphy ultrassonográfico · **coledocolitíase**: colédoco > 6 mm (± cálculo) · **icterícia**: vias dilatadas = obstrutiva; sem dilatação = hepatocelular/hemólise · apendicite: apêndice > 6 mm não compressível · FAST: líquido livre · não vê bridas/pâncreas bem (gás)
TC com contraste	apendicite (> 6 mm, densificação da gordura, apendicolito) · diverticulite (espessamento + densificação; abscesso/ar livre = Hinchey) · obstrução: **ponto de transição** + sofrimento (sinal do bico, alça fechada, pneumatose, parede sem realce, líquido) · pancreatite: **Balthazar**/necrose = área sem realce (após 72 h) · **angio-TC**: falha de enchimento da AMS, pneumatose, gás portal = isquemia
RM / colangio-RM	colangio-RM: bile **branca** (T2), **cálculo = falha de enchimento escura** no colédoco com dilatação acima; estenose; Wirsung em “colar de contas” (pancreatite crônica) · não invasiva, sem contraste iodado, sem radiação (gestante) · **só diagnostica** (quem trata é a CPRE)
EDA	úlcera **benigna**: bordas regulares, fundo limpo, pregas convergindo · **suspeita**: bordas elevadas/irregulares, pregas interrompidas → **biópsia de toda úlcera gástrica** · **Forrest** (Ia jato, Ib babando, IIa vaso visível, IIb coágulo, IIc hematina, III fundo limpo) · esofagite **Los Angeles A–D** (C/D = DRGE confirmada) · **Barrett**: mucosa “salmão” acima da JEG + metaplasia intestinal na biópsia · biópsias: urease/histologia (Hp), duodeno (celíaca, Marsh)
pHmetria / pH-impedância	**tempo de exposição ácida (AET) > 6% = DRGE comprovada** (< 4% normal; 4–6% inconclusivo — Lyon) · DeMeester > 14,7 · associação sintoma-refluxo (SI ≥ 50%, SAP ≥ 95%) · **impedância detecta refluxo NÃO ácido** e o volume · DRGE não comprovada → exame **SEM IBP** (7 d); DRGE já comprovada e sintoma refratário → impedância **COM IBP** · normal + sintomas = pirose funcional/hipersensibilidade
Manometria (alta resolução)	**acalasia** = EEI não relaxa (IRP ↑) + **aperistalse** (Chicago tipos I, II, III) · EEI hipotenso · motilidade ineficaz (fundoplicatura parcial) · esôfago “em britadeira” · **serve antes da fundoplicatura** e na disfagia sem obstrução; **não diagnostica DRGE** · esofagograma na acalasia: “bico de pássaro”
Cintilografia HIDA	vesícula **não aparece** em 4 h = cístico obstruído = colecistite

LABORATÓRIO POR QUADRO: PEDIR E INTERPRETAR

Quadro	Pedir	Interpretar
Abdome agudo	hemograma, PCR, lipase/amilase, BT/frações, FA, GGT, TGO/TGP, Na/K/Cl, ureia/creatinina, **lactato + gasometria**, glicemia, EAS, **β-HCG**, coagulograma, tipagem	leucocitose c/ desvio = inflamatório · **lipase ≥ 3×** = pancreatite (sobe pouco em perfuração/isquemia; não mede gravidade) · **lactato ↑ + acidose** = isquemia/estrangulamento (normal não exclui) · vômitos: **alcalose hipoclorêmica + hipocalemia** · BD + FA/GGT = biliar · hematúria = cólica renal · β-HCG + = ectópica
Diarreia aguda	simples: **nada** · grave: Na, K, ureia/creatinina, gasometria · invasiva/> 7 d/imunossuprimido: coprocultura, leucócitos fecais/calprotectina · pós-ATB: toxina C. difficile · > 14 d: EPF (3 amostras)	hipo/hipernatremia, hipocalemia, **acidose metabólica com AG normal**, ureia/creatinina ↑ = IRA pré-renal · leucócitos fecais/calprotectina + = **inflamatória/invasiva** · gap osmolar fecal > 125 = osmótica, < 50 = secretora
Diarreia crônica	hemograma, ferritina, folato, B12, albumina, **anti-tTG IgA + IgA total**, TSH, calprotectina, EPF, gordura fecal, elastase, H_2 expirado	anemia ferropriva + anti-tTG + = celíaca (→ biópsia, com glúten) · calprotectina ↑ = DII · esteatorreia + elastase ↓ = pancreática
HDA não varicosa	hemograma, **tipagem + prova cruzada**, coagulograma (INR), plaquetas, **ureia**/creatinina, eletrólitos, função hepática, lactato	**Hb inicial pode ser normal** (sem tempo de hemodiluição) → repetir · transfundir se Hb < 7 (< 8 cardiopata) · **ureia ↑ com creatinina normal** = sangue digerido (alta) + hipovolemia · INR ↑ = anticoagulante/hepatopatia · **Glasgow-Blatchford** ≤ 1 = alta ambulatorial
H. pylori	dispepsia < 45 a sem alarme: **teste respiratório ou Ag fecal** (test-and-treat) · em EDA: **urease** + histologia (antro + corpo) · 2 falhas: **cultura/PCR com antibiograma**	falso-negativo se IBP nas últimas **2 semanas** ou ATB/bismuto nas últimas **4 semanas** · sorologia = só contato prévio (fica + após curar) → não serve p/ controle · controle de cura ≥ 4 sem após o fim
Via biliar / pâncreas	BT/frações, FA, GGT, TGO/TGP, INR, albumina, lipase, hemograma, PCR	FA/GGT + BD ↑ = colestase · **ALT > 150 na pancreatite = biliar** · ver icterícia e Tóquio

COMO ESCREVER A DISCURSIVA

- Uma discursiva por SP, sempre um caso com itens a–e. Os temas se repetem: **SP1 obstrução intestinal** (3/3) · **SP2 celíaca** (2/3) ou parasitose · **SP3 icterícia/coledocolitíase/pancreatite biliar** (3/3) · **SP4 HDA** (2/3) ou úlcera + H. pylori.
- Responda **exatamente o que o item lista**: se pede “regime, exames e tratamento”, escreva os três. “Síndrome” é síndrome (obstrutiva, colestática), não a doença.
- Diagnóstico sempre com **justificativa** (achados do caso). Conduta com **local** (UBS/enfermaria/UTI), **prescrição com droga + dose + via + intervalo + duração** e o **procedimento definitivo** com o momento (CPRE, colecistectomia na mesma internação, EDA em 24 h).
- “Cite 5” → escreva 5–6 (a correção é por item). Complicações: separe locais × sistêmicas quando pedir.
- Erros que já custaram ponto: colangite → colecistectomia · enfermaria com Ranson 4 · complicação de pancreatite crônica na aguda · “albendazol 14 dias” · EDA sem a finalidade terapêutica · “Mirizzi” quando pedia síndrome · simeticona na obstrução · USG “vendo” bridas.